

23. DESARROLLO DEL ESÓFAGO

DURACIÓN : 07:43

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad el desarrollo del esófago, destacando su papel esencial como articulación entre la mente y el corazón. Se aborda el impacto de la flexión embrionaria en el tronco, que da forma al sistema digestivo y permite la formación de los pulmones y el esófago. Se hace hincapié en la estructura adaptativa del esófago, su vínculo con el diafragma y las consecuencias de las disfunciones, especialmente en lo que respecta al reflujo y los problemas otorrinolaringológicos. Las interacciones dinámicas entre el esófago, la tráquea y la aorta revelan una complejidad rítmica que es crucial para nuestra salud global. A través de conceptos clave como el plexo vagal y la vasculatura peritoneal, esta lección resalta la importancia del sistema embrionario para la práctica osteopática.

DESARROLLO DEL ESÓFAGO

El desarrollo del **esófago** es una articulación entre la **mente** y el **corazón**. La **aorta** juega un papel central en este sistema, mientras que la **cavidad amniótica** ejerce una presión externa. Entre estos dos elementos, el **cerebro** orienta el desarrollo y el **corazón** sirve de punto de apoyo.

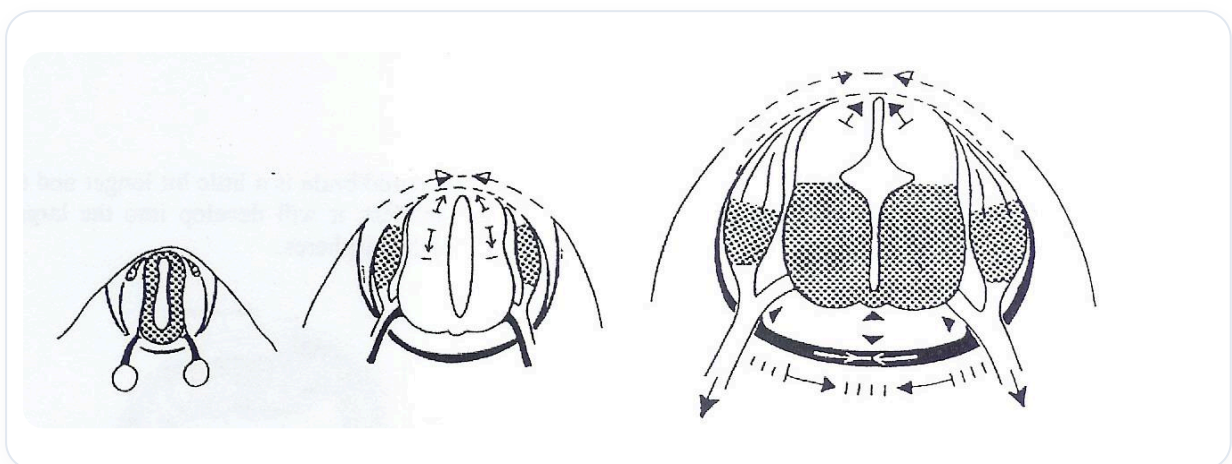


FIG. — Gastrulación neurulación invaginación

Anteriormente estudiamos la influencia de la aplicatura del movimiento de flexión del embrión a nivel de la cabeza. Ahora, examinaremos la influencia de esta aplicatura a nivel del **tronco**. Este movimiento de flexión genera diversos fenómenos digestivos.

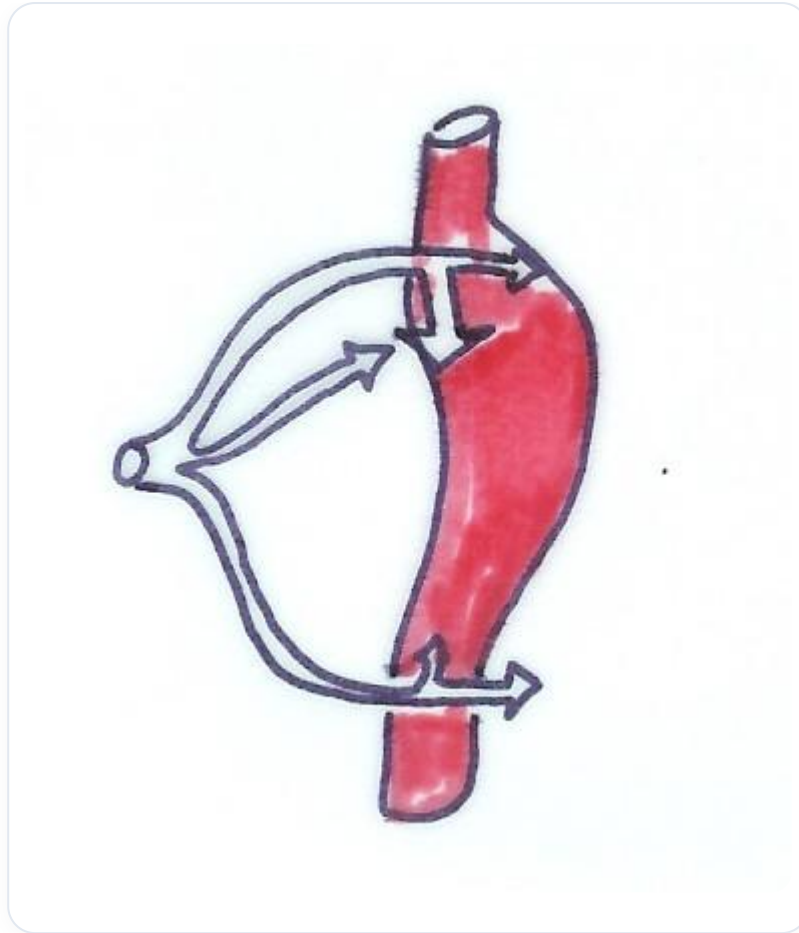


FIG. — *Circulación fetal*

Uno de los primeros fenómenos digestivos a estudiar es el desarrollo de los **pulmones**, que pueden considerarse como una glándula. Este movimiento de flexión implica la **cavidad amniótica**, la **cavidad vitelina** y el **corazón**. Observamos la aparición del **tubo digestivo anterior** con divertículos. Progresivamente, se delinean una zona pulmonar y una zona digestiva.

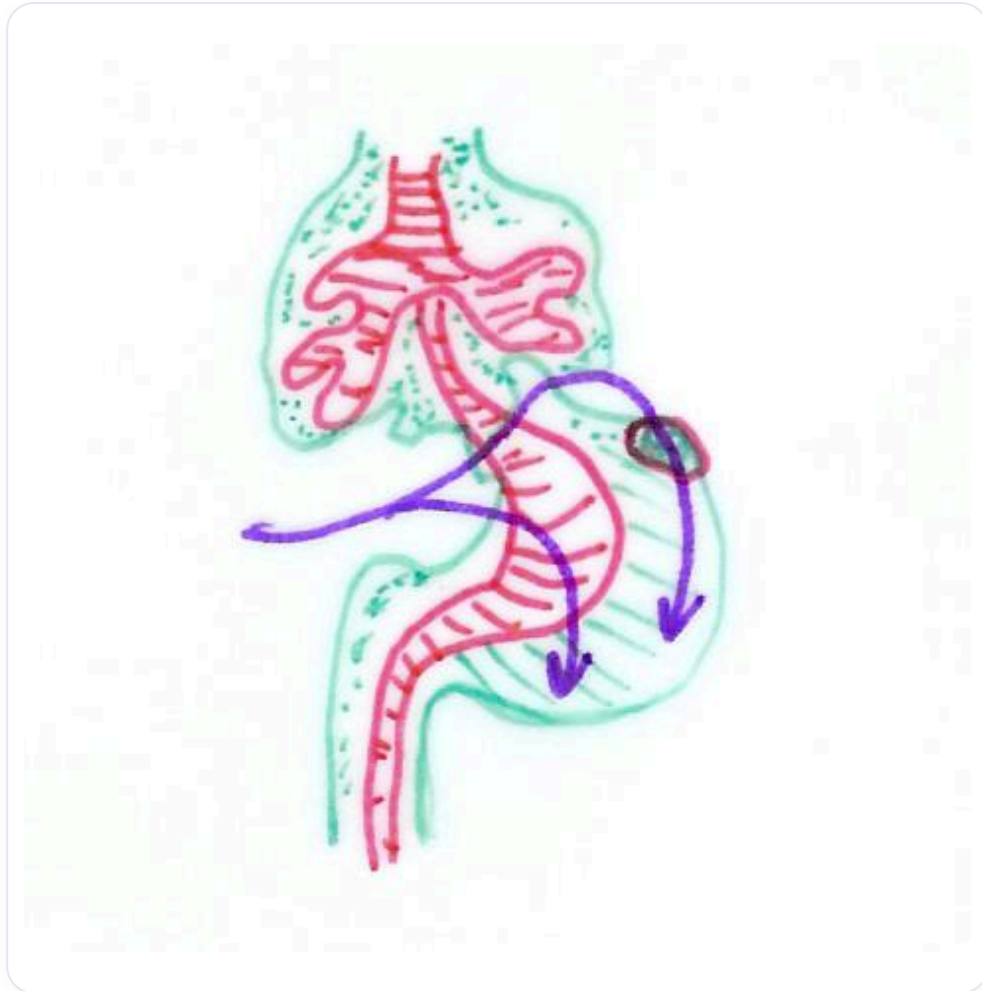


FIG. — Circulación fetal

El **esófago** se desarrolla a partir del segmento del **intestino primitivo**, situado entre el **divertículo respiratorio** y la dilatación del **estómago**. Está constituido por una parte **endoblástica** (tejido interno) y un **mesénquima** (tejido conjuntivo, muscular y fibroso). El epitelio forma la parte interna, mientras que alrededor se encuentra un tejido que contribuye a su estructura.

El **esófago** presenta cierta adaptabilidad a su entorno. Sin embargo, muchos problemas a nivel de la unión esofágica están relacionados con la relación con el **diafragma**. Estas disfunciones pueden provocar problemas **ORL**, como otitis, rinitis e incluso reflujo gástrico. Elementos como la **pepsina** y el **ácido clorhídrico** se han encontrado en el oído medio de algunos niños, lo que subraya el vínculo entre el reflujo y los problemas ORL.

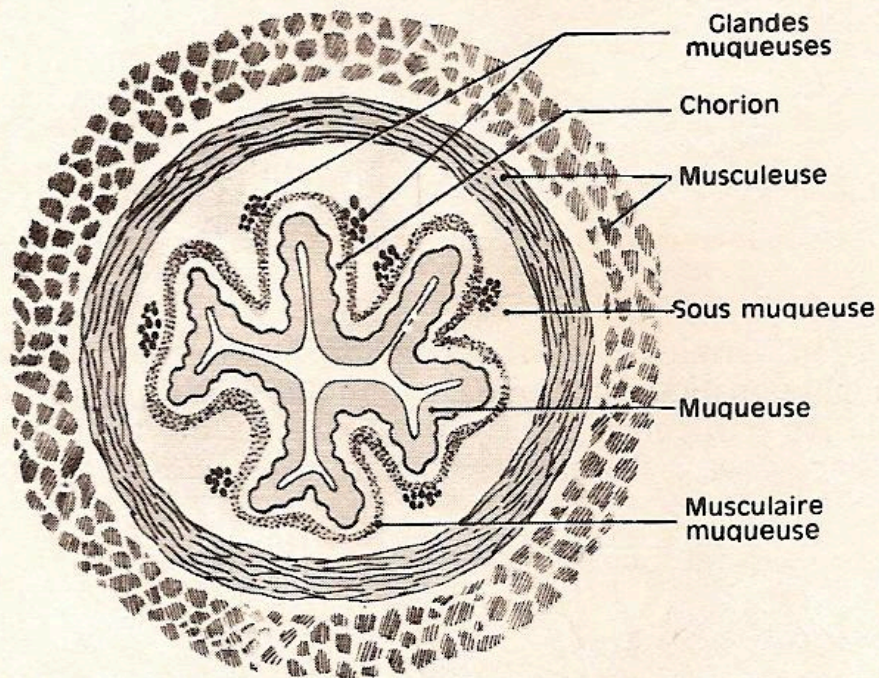


FIG. 53. — Coupe transversale de l'œsophage.

FIG. — Corte de esófago

Es importante señalar que el reflujo no siempre se manifiesta con ardor. De hecho, algunos reflujos son de tipo gaseoso, implicando moléculas de gas que ascienden por el sistema. Esto se debe a menudo a una disfunción a nivel de la unión entre el esófago y el estómago, a nivel diafragmático.

Corte frontal esquemático del hiato esofágico.

- 1 Porción derecha del diafragma.
- 2 Músculo de Rouget y Juvara derecho.
- 3 Peritoneo.
- 4 Cardioesófago.
- 5 Válvula de Gubaroff.
- 6 Músculo de Rouget y Juvara izquierdo.
- 7 Espacio periesofágico.
- 8 Vaina de Treitz y Leimer (lado izquierdo).
- 9 Vaina de Treitz y Leimer (lado derecho).
- 10 Pleura.

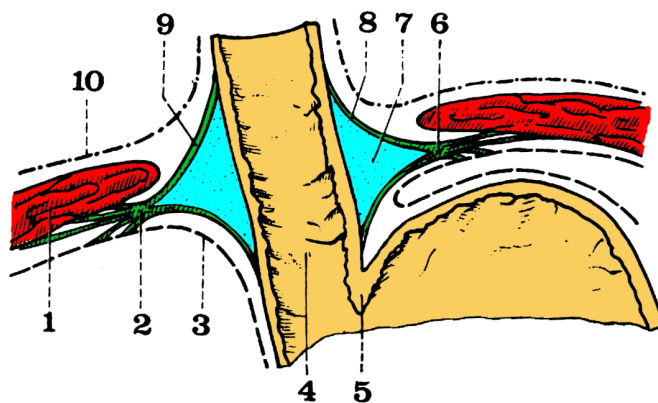


FIG. — Hiato esofágico

La **unión diafragmática** es crucial, ya que está relacionada con las **fibras de Juvara** y el espacio **periesofágico**, que es adaptativo. Una disfunción a este nivel puede bloquear la calidad y la apertura del diafragma. Steele dijo: "Si tu diafragma no está libre, la puerta de tu vida no está libre."

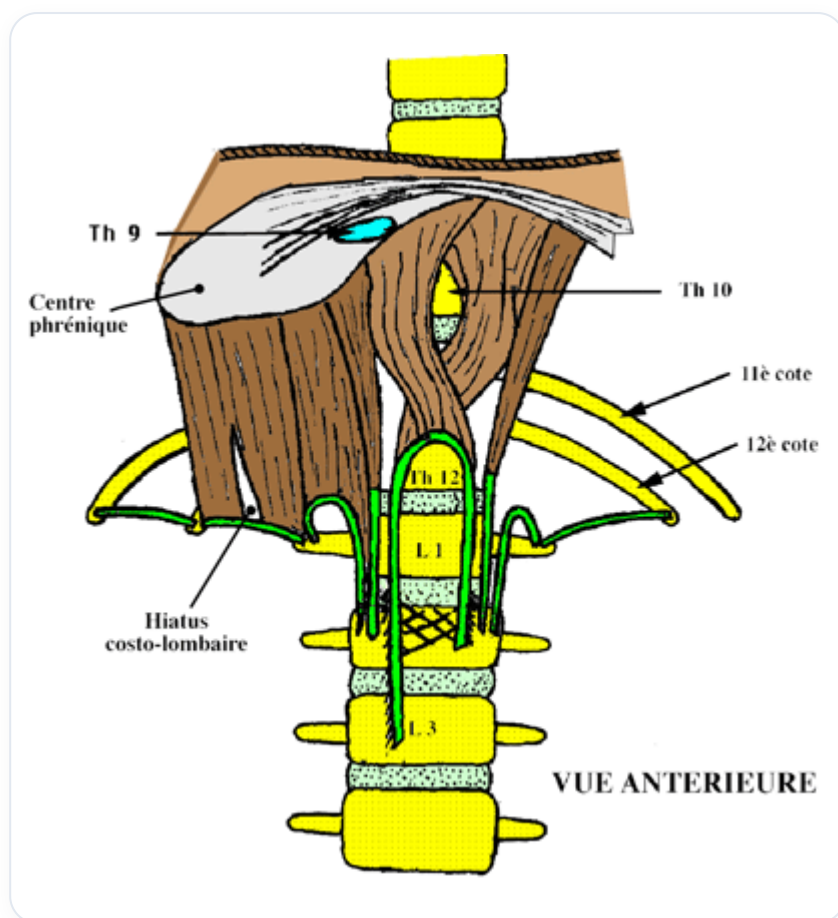


FIG. — Diafragma en vista anterior

El **plexo vagal** también es muy importante. El **esófago**, la **tráquea** y la **aorta** están interconectados, formando una zona rítmica. Esta zona se mantiene por una **fascia común** y un **mesenterio posterior**, que se insertan en la zona dorsal media, alrededor de D3-D4.

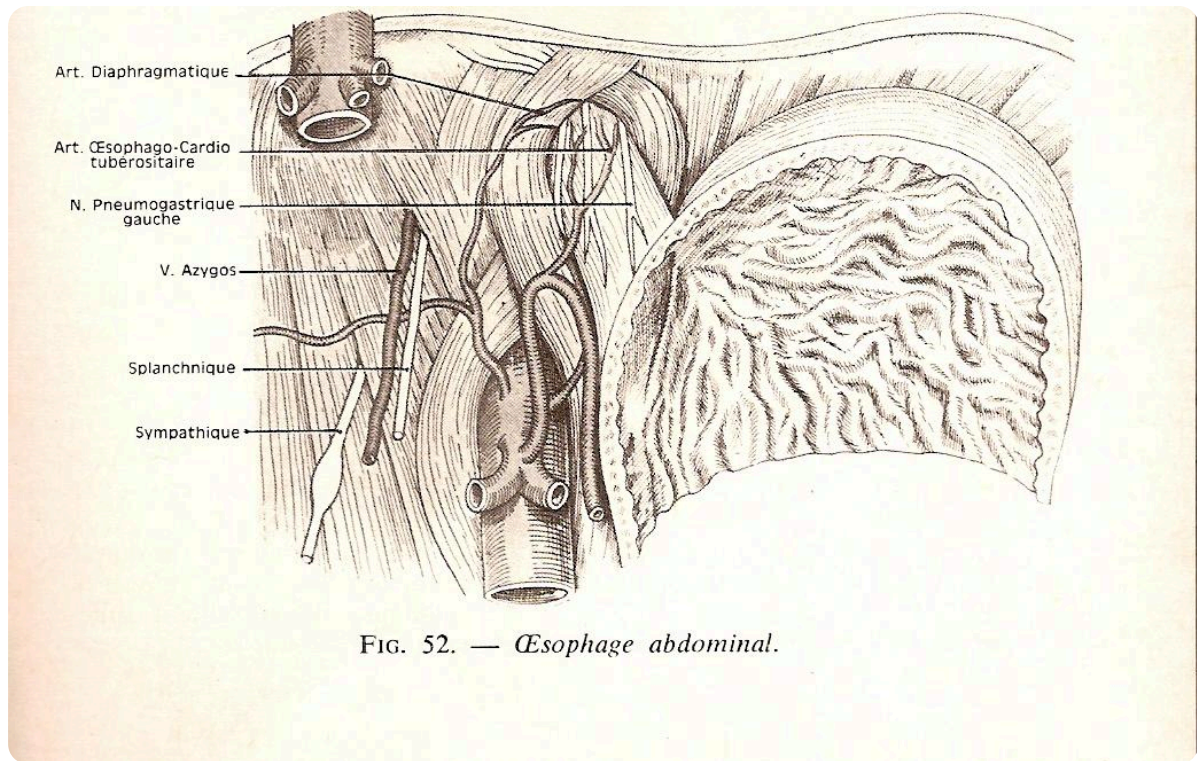


FIG. 52. — Œsophage abdominal.

FIG. — Esófago abdominal

El **esófago** está implicado en la deglución, la **tráquea** en la respiración y la **aorta** en el movimiento del corazón. Estas interacciones se producen miles de veces al día, creando una dinámica rítmica compleja.

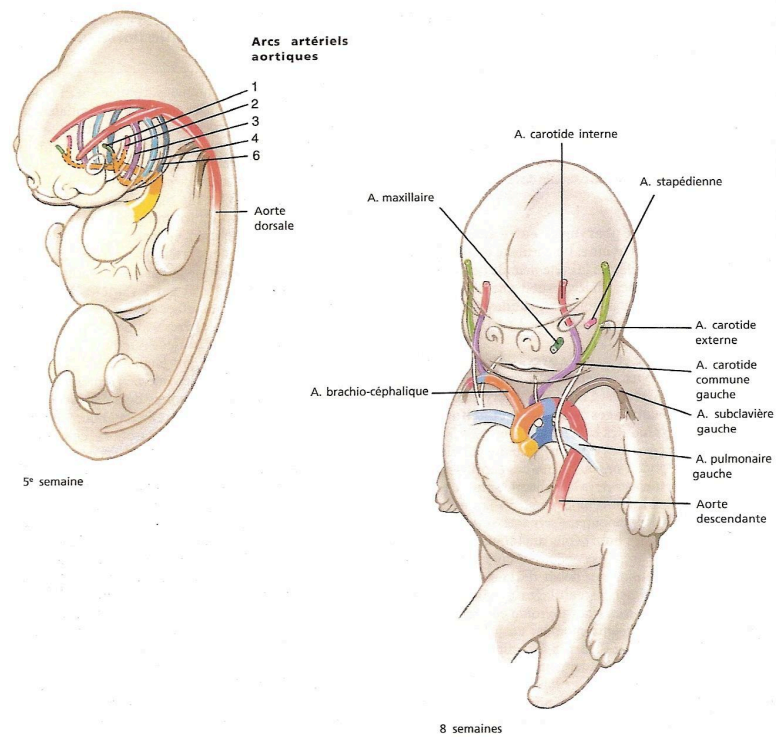


Fig. 12 - 6. Devenir des artères des arcs pharyngiens. Ces artères se modifient pour être à l'origine de celles de la partie supérieure du thorax, du cou et de la tête (voir Ch. 8).

FIG. — Arcos aórticos embrionarios

También tenemos una continuidad directa con el sistema aórtico, así como un ligamento que se extiende hacia la **cuarta porción del duodeno**, abriendo una zona importante a nivel del **tronco celíaco**. Este último es esencial para la vascularización de la parte peritoneal subdiafragmática, irrigando el **hígado** y el **estómago**.

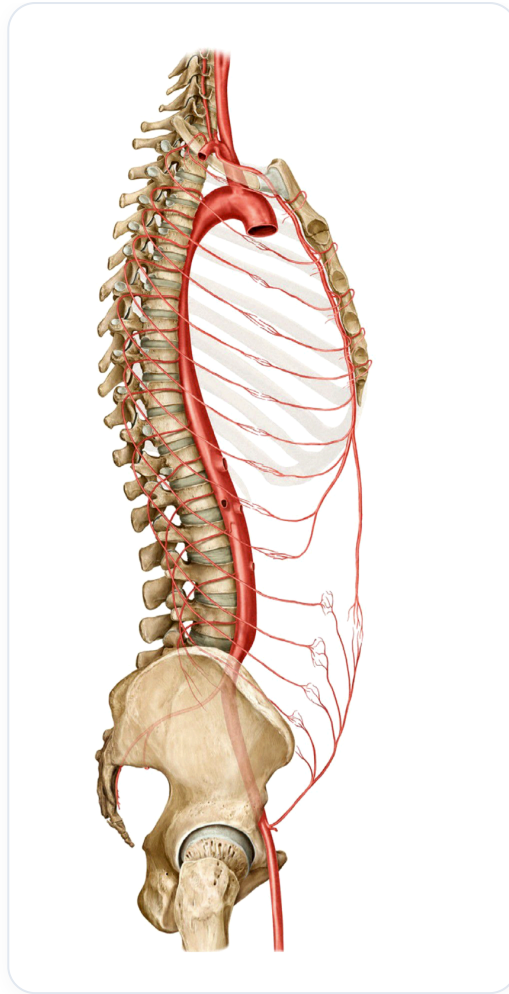


FIG. — Aorta, arco, intercostales

Finalmente, abordaremos el estudio de los **pulmones**, revisando las diferentes capas del esófago y su importancia en el desarrollo global del sistema digestivo.

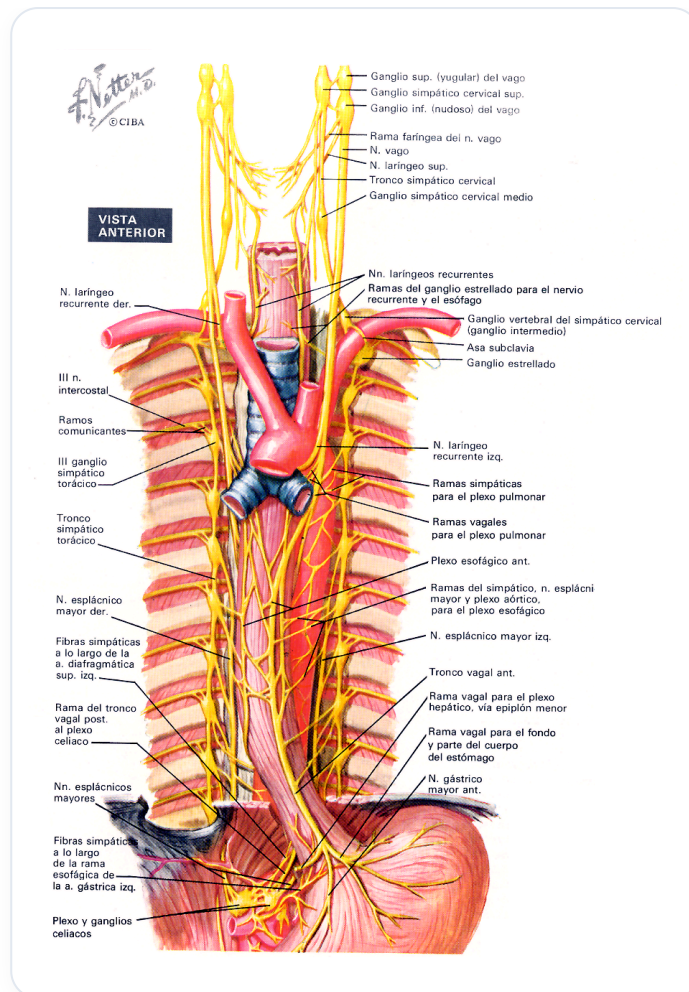


FIG. — *Inervación torácica y abdominal*